



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

Saúde Digital da Secretaria da Saúde

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD

Elaborado em conformidade com a instrução normativa ses nº 01, de 21 de janeiro de 2026.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E TELEDIAGNÓSTICO – 2026

Identificação do DFD	Nº 03/2026
Data de elaboração	19/02/2026
Processo SEI	3552205.404.00021440/2026-96
Área Requisitante	Secretaria Municipal da Saúde – Saúde Digital
Unidade/Setor Requisitante	Saúde Digital
Responsável pela Demanda	Camila Cruz
Cargo	Supervisora de Área - Saúde Digital
Matrícula	467087
E-mail institucional	saudedigital@sorocaba.sp.gov.br
Telefone	(15) 3238-2817
Grau de Prioridade da Contratação	☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa

1. IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE

A necessidade da contratação decorre de diagnóstico técnico consolidado realizado pela Central de Regulação Eletiva e Divisão de Avaliação e Controle (CREDAC), com base na análise sistemática da produção assistencial, das inserções regulatórias, da demanda reprimida registrada e da série histórica de encaminhamentos à atenção especializada.

O Município de Sorocaba apresenta crescimento populacional contínuo, acompanhado de progressivo

envelhecimento demográfico e ampliação da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, fatores que exercem pressão direta sobre a demanda por consultas especializadas e exames diagnósticos.

O levantamento técnico mais recente identificou a ocorrência de 42.055 inserções anuais para primeira consulta especializada, associadas a 52.340 solicitações represadas aguardando agendamento no sistema regulatório municipal. Esses dados evidenciam desequilíbrio estrutural entre a demanda encaminhada pela Atenção Primária e demais pontos da rede e a capacidade instalada atualmente disponível para atendimento presencial especializado.

A projeção da necessidade real, considerando o ciclo assistencial completo, que compreende consulta inicial e consultas de retorno, demonstra volume substancialmente superior à oferta presencial instalada. Esse descompasso estrutural tem resultado na formação contínua de fila reprimida em diversas especialidades médicas, com impacto direto sobre o tempo médio de espera.

Verifica-se que o tempo de espera observado para determinados atendimentos mostra-se incompatível com os princípios da integralidade, continuidade e oportunidade do cuidado preconizados pelo Sistema Único de Saúde, podendo acarretar atraso diagnóstico, progressão clínica de doenças crônicas, agravamento de quadros potencialmente controláveis e aumento da complexidade terapêutica futura.

No âmbito do apoio diagnóstico, exames como Eletrocardiograma (ECG), Espirometria, Holter 24 horas e Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA) apresentam demanda regulada superior à capacidade operacional de realização e emissão de laudos, comprometendo a definição adequada de condutas clínicas e seguimento especializado.

Ressalte-se que a insuficiência identificada não decorre de ausência de organização do fluxo regulatório, mas de limitação quantitativa da oferta assistencial frente ao volume de encaminhamentos provenientes da Atenção Primária e dos demais pontos da Rede de Atenção à Saúde.

Diante desse cenário, caracteriza-se a necessidade administrativa de contratação de solução estruturada de teleconsultas médicas especializadas e telediagnóstico, como medida complementar à rede presencial existente, destinada à ampliação da capacidade assistencial, qualificação do fluxo regulatório e redução progressiva da demanda reprimida, sem substituição da assistência presencial regularmente ofertada.

2. JUSTIFICATIVA / MOTIVO DA DEMANDA

A presente demanda fundamenta-se na obrigação constitucional do poder público de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, bem como na responsabilidade administrativa de planejar adequadamente as contratações públicas, conforme preconiza a Lei nº 14.133/2021.

A limitação da oferta presencial, associada ao crescimento da demanda especializada, evidencia a necessidade de adoção de estratégia complementar que permita ampliar o acesso sem depender exclusivamente da expansão física da infraestrutura municipal ou da imediata ampliação do quadro presencial de especialistas, cuja viabilidade encontra restrições práticas relacionadas à disponibilidade de profissionais no mercado e à capacidade orçamentária.

A telemedicina especializada e o telediagnóstico encontram respaldo na legislação federal vigente, nas diretrizes do SUS Digital e nas políticas nacionais de Telessaúde, constituindo instrumento regulado e reconhecido de ampliação do acesso, desde que observados os requisitos técnicos, éticos e de segurança da informação.

A solução proposta não substitui a assistência presencial, mas atua como mecanismo estruturado de

ampliação da oferta, com potencial de reduzir filas, melhorar o fluxo regulatório e qualificar a tomada de decisão clínica.

3. RISCOS DA NÃO CONTRATAÇÃO

A não implementação da contratação ora proposta poderá acarretar consequências assistenciais, administrativas e financeiras relevantes.

Do ponto de vista assistencial, a manutenção de tempos de espera prolongados pode resultar em agravamento de quadros crônicos, progressão de doenças cardiovasculares, neurológicas e metabólicas, aumento de complicações evitáveis e maior complexidade terapêutica futura.

Sob a perspectiva sistêmica, a demora no acesso especializado tende a gerar maior pressão sobre serviços de urgência e emergência, além de contribuir para aumento de internações potencialmente evitáveis, com repercussão direta no custo hospitalar.

Há, ainda, risco de crescimento de judicializações individuais para garantia de acesso a consultas e exames, o que pode implicar decisões judiciais com maior custo unitário e menor previsibilidade orçamentária.

Do ponto de vista administrativo, a manutenção do passivo assistencial compromete a eficiência na utilização dos recursos públicos e dificulta o cumprimento de metas assistenciais previstas nos instrumentos de planejamento.

4. OBJETO

O objeto da presente demanda consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de teleconsultas médicas especializadas e telediagnóstico (Eletrocardiograma (ECG), Espirometria, Holter 24 horas e Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial (MAPA), destinados ao atendimento da demanda regulada da rede municipal de saúde de Sorocaba.

A contratação compreenderá a disponibilização de plataforma tecnológica interoperável para realização dos atendimentos e emissão de laudos, a execução das teleconsultas por médicos especialistas devidamente habilitados, a emissão de laudos diagnósticos por profissionais legalmente qualificados, bem como o fornecimento, em regime de comodato, dos equipamentos médicos e tecnológicos indispensáveis à execução dos exames e à operacionalização da solução, incluindo manutenção e suporte técnico.

Os equipamentos disponibilizados em comodato permanecerão sob responsabilidade da contratada, vinculados exclusivamente à execução contratual, não configurando aquisição patrimonial pelo Município.

A execução deverá ocorrer de forma complementar à rede assistencial presencial existente, não implicando delegação da gestão pública dos serviços de saúde nem substituição integral da assistência especializada ofertada pelo Município.

5. ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS

5.1 Teleconsulta

O levantamento técnico consolidado da regulação municipal identificou necessidade anual estimada de 241.558 consultas especializadas, considerando inserções anuais para primeira consulta, fila reprimida registrada e projeção do ciclo assistencial completo com consultas de retorno.

Esse quantitativo representa a necessidade potencial total da rede municipal, caso houvesse capacidade instalada suficiente para absorção integral da demanda regulada.

Todavia, considerando:

- a capacidade orçamentária disponível no exercício;
- a estratégia de implementação gradual da solução;
- a necessidade de monitoramento de desempenho contratual;
- e a manutenção da oferta presencial existente,

optou-se por dimensionar a contratação inicial em aproximadamente 30% da necessidade total apurada, correspondente a 72.469 teleconsultas anuais.

O detalhamento por especialidade é apresentado a seguir:

Tabela 1: Necessidade Total x Dimensionamento Inicial (30%)

Especialidade	Necessidade Total	30%	Custo Médio	Valor Total
Alergo e Imunologia Adulto	1.120	336	R\$ 95,00	R\$ 31.920,00
Alergo e Imunologia Infantil	2.524	757	R\$ 110,00	R\$ 83.292,00
Cardiologia Adulto	22.096	6.630	R\$ 93,00	R\$ 616.478,40
Dermatologia	52.355	15.706	R\$ 93,00	R\$ 1.460.704,50
Endocrinologia Adulto	15.092	4.527	R\$ 102,00	R\$ 461.815,20
Gastro/Hepatologia	525	157	R\$ 125,00	R\$ 19.687,50
Genética Infantil	203	61	R\$ 93,00	R\$ 5.663,70
Hematologia Adulto	3.313	994	R\$ 104,00	R\$ 103.365,60
Nefrologia Adulto	9.836	2.951	R\$ 115,00	R\$ 339.342,00
Neuro Infantil	14.719	4.416	R\$ 133,00	R\$ 587.288,10
Neurologia Adulto	32.606	9.782	R\$ 106,00	R\$ 1.036.870,80
Ortopedia Adulto	8.420	2.526	R\$ 87,00	R\$ 219.762,00
Otorrinolaringologia	18.430	5.530	R\$ 97,00	R\$ 536.313,00
Psiquiatria	16.506	4.952	R\$ 105,00	R\$ 519.939,00
Reumatologia Adulto	13.199	3.960	R\$ 105,00	R\$ 415.768,50
Urologia Adulto	11.636	3.490	R\$ 97,00	R\$ 338.607,60
Cirurgia Vascular	18.978	5.694	R\$ 102,00	R\$ 580.726,80
Total	241.558	72.469		R\$ 7.357.544,70

5.2 Telediagnóstico

No que se refere ao telediagnóstico, a estimativa anual de exames foi construída com base na demanda regulada consolidada, na série histórica de solicitações e na capacidade operacional estimada para ampliação da oferta.

Os valores unitários foram obtidos por meio de pesquisa de mercado, com comparação aos incentivos previstos na Tabela SUS Paulista (SIGTAP), permitindo identificar eventual necessidade de complementação municipal.

Segue a estimativa preliminar:

Tabela 2: Estimativa de exames, quantidades e valores médios

Exame	Previsão Anual	Valor Médio de Mercado	Incentivo SUS Paulista	Complemento Municipal	Valor Estimado da Contratação	Valor Estimado do Complemento
ECG	22.200	R\$ 3,76	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 83.472,00	R\$ 0,00
Espirometria	4.700	R\$ 14,35	R\$ 12,72	R\$ 1,63	R\$ 67.445,00	R\$ 7.661,00
Holter	3.900	R\$ 65,00	R\$ 60,00	R\$ 5,00	R\$ 253.500,00	R\$ 19.500,00
MAPA	2.050	R\$ 36,50	R\$ 20,14	R\$ 16,36	R\$ 74.825,00	R\$ 33.538,00
TOTAL					R\$ 479.242,00	R\$ 60.699,00

Total Estimado da Contratação: R\$ 479.242,00

Total Estimado de Complemento Municipal: R\$ 60.699,00

Obs.: Códigos SIGTAP – ECG 02.11.02.003-6; Espirometria 02.11.08.005-5; Holter 02.11.02.004-4; MAPA 02.11.02.005-2.

Os quantitativos estão fundamentados em levantamento técnico consolidado e memória de cálculo constante do processo administrativo, destinando-se ao adequado planejamento da contratação.

6. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO CUSTO

A estimativa preliminar do valor da contratação para o período de 12 (doze) meses foi construída com base na multiplicação dos quantitativos projetados por especialidade e por exame pelos valores unitários obtidos mediante pesquisa de mercado estruturada.

A pesquisa contemplou consultas formais a fornecedores especializados em serviços de telemedicina, bem como análise de contratos públicos similares disponíveis em bases oficiais, incluindo o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

Foram considerados valores apresentados por diferentes empresas do setor, conforme demonstrado na planilha comparativa constante do processo, abrangendo as seguintes referências: Rede Íntegra Saúde, Globalmed, Docway e Top Med.

A metodologia adotada consistiu na comparação dos valores globais estimados por fornecedor, considerando a totalidade dos quantitativos projetados para 12 meses, sendo adotado como parâmetro estimativo o menor valor global obtido na pesquisa, em observância aos princípios da economicidade e da razoabilidade administrativa.

O valor estimado anual resultante corresponde a R\$ 7.836.786,70, sendo:

- R\$ 7.357.544,70 relativos às teleconsultas especializadas;
- R\$ 479.242,00 referentes ao telediagnóstico.

No caso dos exames diagnósticos, a estimativa considerou, adicionalmente, os valores previstos na Tabela SUS Paulista (SIGTAP), identificando eventual necessidade de complemento municipal, conforme detalhamento constante da tabela específica.

Ressalte-se que o valor ora indicado possui caráter preliminar e estimativo, destinado ao planejamento da contratação e à verificação de compatibilidade orçamentária, não se confundindo com o preço final contratual, que será definido mediante regular procedimento licitatório, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

A estimativa da despesa encontra-se prevista para inclusão na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, conforme planejamento já realizado pela Secretaria Municipal da Saúde e inserido como prioridade na proposta orçamentária subsequente, assegurando a viabilidade financeira da execução contratual.

7. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A presente demanda encontra-se alinhada ao Plano Municipal de Saúde vigente, especialmente no eixo estratégico voltado à ampliação do acesso à atenção especializada e à redução da demanda reprimida, bem como à Programação Anual de Saúde correspondente ao exercício, ao Plano Plurianual (PPA) 2026–2029 e à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, observada a compatibilidade orçamentária.

Sob o aspecto normativo, a contratação encontra respaldo no marco regulatório nacional da Telessaúde, notadamente:

- na Lei Federal nº 14.510/2022, que alterou a Lei nº 8.080/1990 para autorizar e disciplinar a prática da telessaúde em todo o território nacional;
- na Resolução CFM nº 2.314/2022, que regulamenta a telemedicina e estabelece requisitos éticos, técnicos e operacionais para teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico e demais modalidades;
- na Lei Federal nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais e dados sensíveis, assegurando sigilo, segurança e governança das informações de saúde;
- na Portaria GM/MS nº 1.348/2022, que dispõe sobre as ações e serviços de Telessaúde no âmbito do SUS;
- na Portaria GM/MS nº 1.434/2020, que instituiu o Programa Conecte SUS e a Rede Nacional de Dados

em Saúde (RNDS), estabelecendo padrões de interoperabilidade;

- na Portaria GM/MS nº 3.232/2024, que instituiu o Programa SUS Digital, orientando a transformação digital dos serviços de saúde.

No âmbito municipal, a prática da telemedicina encontra fundamento na Lei Municipal nº 12.747/2023, atualmente em fase de atualização e regulamentação por meio de Decreto, reforçando a legitimidade da adoção de soluções de telessaúde como instrumento complementar de ampliação do acesso assistencial.

Dessa forma, a presente demanda não representa inovação isolada, mas insere-se em arcabouço jurídico consolidado, nacional e municipal, que autoriza e regulamenta a utilização de tecnologias digitais para qualificação da assistência em saúde.

8. PARCELAMENTO

A solução pretendida constitui objeto funcionalmente integrado, composto por plataforma tecnológica interoperável, teleconsultas médicas especializadas, serviços de telediagnóstico, fornecimento de equipamentos em comodato, suporte técnico, manutenção e governança de dados sensíveis.

Os componentes descritos possuem dependência operacional e tecnológica contínua, exigindo interoperabilidade em tempo real, rastreabilidade assistencial e responsabilização contratual única.

A eventual fragmentação da contratação em lotes distintos implicaria:

- necessidade de múltiplas integrações tecnológicas entre fornecedores diversos;
- aumento de custos indiretos relacionados a interfaces, customizações e suporte;
- maior risco de incompatibilidade sistêmica;
- dificuldade de atribuição de responsabilidade em casos de falha técnica ou evento assistencial;
- aumento da complexidade fiscalizatória;
- risco de descontinuidade do serviço em caso de inadimplemento parcial.

Experiências de mercado e contratações similares no âmbito do SUS demonstram que soluções fragmentadas de telessaúde tendem a demandar contratos adicionais de integração, elevando o custo global da solução e reduzindo sua eficiência operacional.

Dessa forma, sob os aspectos técnico, operacional e econômico, o parcelamento não se mostra vantajoso à Administração, sendo recomendada a contratação unificada da solução, com responsabilização integral da futura contratada.

Eventual subcontratação deverá restringir-se a atividades acessórias, permanecendo sob responsabilidade integral da contratada a execução do núcleo essencial do objeto.

A integração entre plataforma tecnológica, corpo profissional habilitado e equipamentos médicos específicos configura solução funcionalmente indissociável. A disponibilização dos equipamentos em regime de comodato constitui condição essencial para a execução do serviço, sendo tecnicamente inadequada sua contratação ou aquisição de forma isolada, sob pena de comprometer a interoperabilidade, a governança de dados e a continuidade assistencial.

9. RESULTADOS ESPERADOS

A presente contratação tem por finalidade alcançar resultados concretos, mensuráveis e verificáveis, relacionados à economicidade, à eficiência operacional e ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros do Município de Sorocaba, nos termos do art. 18, §1º, inciso IX, da Lei nº 14.133/2021.

Os resultados pretendidos foram definidos com base no diagnóstico técnico consolidado da regulação municipal, que identificou 42.055 inserções anuais de primeira consulta especializada e 52.340 solicitações represadas aguardando agendamento, bem como na projeção de 241.558 consultas como necessidade assistencial potencial.

A solução proposta, dimensionada inicialmente para absorver aproximadamente 30% da necessidade total identificada, visa produzir impacto progressivo sobre o tempo médio de espera, a ampliação do acesso especializado e a redução de ineficiências operacionais.

9.1 Resultados esperados e indicadores de desempenho

Resultado Pretendido	Indicador	Meta Inicial	Prazo de Avaliação
Redução do tempo médio de espera para consultas especializadas	Tempo médio de espera (dias)	Redução de 30%	12 meses
Ampliação da oferta de consultas especializadas	Número de consultas realizadas/mês	Aumento mínimo de 30%	12 meses
Redução do absenteísmo	Taxa de absenteísmo (%)	Redução de 10%	12 meses

Os indicadores acima permitirão aferição objetiva da efetividade da contratação, mediante comparação entre o cenário anterior e posterior à implementação da solução.

9.2 Economicidade e racionalização de recursos

A economicidade da contratação decorre de múltiplos fatores:

- redução do custo indireto associado à manutenção prolongada de fila reprimida;
- mitigação de internações potencialmente evitáveis decorrentes de atraso diagnóstico;
- diminuição de judicializações individuais para acesso a consultas especializadas;
- pagamento por produção efetivamente realizada, evitando ociosidade contratual;
- aproveitamento da estrutura física já existente nas unidades municipais.

A solução também permitirá melhor aproveitamento dos recursos humanos municipais, ao:

- otimizar o tempo assistencial por meio de atendimentos remotos estruturados;
- reduzir deslocamentos desnecessários de pacientes e profissionais;
- permitir redistribuição estratégica da força de trabalho presencial para casos de maior complexidade;

- integrar dados clínicos em plataforma interoperável, reduzindo retrabalho e perda de informações.

A utilização de teleconsultas e telediagnóstico não implica substituição do corpo clínico municipal, mas complementação estratégica da oferta, contribuindo para maior eficiência sistêmica e sustentabilidade financeira.

10. PRAZO PRETENDIDO PARA EXECUÇÃO APÓS CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Considerando o cenário assistencial identificado e o volume de demanda reprimida existente, o prazo pretendido para início da execução contratual é de até 60 (sessenta) dias após a celebração do contrato, contemplando o período necessário para implantação da plataforma tecnológica, integração com os sistemas municipais e início da operação assistencial.

O cronograma detalhado de implantação e operação será definido no Estudo Técnico Preliminar e consolidado no Termo de Referência, observadas as especificidades técnicas da solução e os prazos compatíveis com a continuidade do serviço público.

11. MODALIDADE / ENQUADRAMENTO LEGAL (DEFINIÇÃO PELA ÁREA COMPETENTE)

A presente demanda possui natureza de prestação de serviço técnico especializado, de caráter continuado, envolvendo solução integrada de teleconsultas médicas especializadas e telediagnóstico, com suporte tecnológico e operacional.

Compete à área técnica de planejamento de contratações e à autoridade competente a definição da modalidade de contratação e do enquadramento legal aplicável, nos termos da Lei nº 14.133/2021, observadas as características do objeto, sua natureza comum ou especial e os critérios legais pertinentes.

A área demandante limita-se, neste documento, à caracterização da necessidade administrativa e à estimativa preliminar de quantitativos e custos, sem definição prévia da modalidade licitatória.

12. VINCULAÇÃO OU DEPENDÊNCIA COM OUTRO DFD

A presente demanda não possui vinculação direta ou dependência formal com outro Documento de Formalização da Demanda registrado até o momento, não se tratando de fracionamento de objeto ou desmembramento artificial de contratação correlata.

13. CONCLUSÃO

Diante do diagnóstico técnico consolidado da regulação municipal, que identificou volume significativo de inserções anuais para consultas especializadas, elevado quantitativo de solicitações represadas e insuficiência da oferta instalada frente à necessidade assistencial projetada, resta caracterizada a necessidade administrativa de ampliação estruturada da capacidade especializada da rede municipal.

A demanda ora formalizada visa enfrentar cenário de desequilíbrio entre oferta e procura por consultas médicas especializadas e exames diagnósticos, contribuindo para redução progressiva da fila reprimida, melhoria da oportunidade do cuidado e mitigação de riscos assistenciais decorrentes de atrasos diagnósticos.

A solução pretendida possui caráter complementar à rede presencial existente, não implicando substituição

da assistência municipal regularmente ofertada, mas ampliando sua capacidade de resposta de forma proporcional à realidade orçamentária e às diretrizes estratégicas da política pública de saúde.

A estimativa preliminar de quantitativos e custos foi construída com base em dados consolidados, pesquisa de mercado estruturada e compatibilização com os instrumentos de planejamento vigentes, demonstrando viabilidade técnica e orçamentária da formalização da demanda.

Assim, conclui-se pela necessidade de prosseguimento do processo administrativo, com elaboração do Estudo Técnico Preliminar e demais instrumentos previstos na Lei nº 14.133/2021 e na Instrução Normativa SES nº 01/2026.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2026.

Camila Cruz

Supervisora de Área de Saúde

14. IDENTIFICAÇÃO, CIÊNCIA E AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

João Pedro Arruda Fraletti Miguel

Secretário da Saúde



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cruz, Supervisor**, em 19/02/2026, às 12:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no [Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023](#) e [Decreto Municipal de regulamentação do processo eletrônico](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cidades.sei.sp.gov.br/sorocaba/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **1415696** e o código CRC **919BD7A0**.

Referência: Processo nº 3552205.404.00021440/2026-96

SEI nº 1415696